

() ACOMPANHAMENTO (X) CONSULTA
NS

Luiz Eduardo Oliveira Gonçalves

IDADE: 61 PESO: 126 ALTURA: 179 PROFISSÃO: Comerciante
SINTOMAS: Refluxo gástrico / Causado e dor nas costas
QUEIXAS: sonolência / acordar cansado / ↓ da memória
MEDICAMENTOS: Bioncor / Daflonil / ↓ libido.

HAS

MÉDICO: Dr. Erico

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Bike 2x / Hidrog. 1x

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: - JANTAR: 5

HORA QUE DORME: 21:30 HORA QUE ACORDA: 6:30

COCHILHO (X) SIM () NÃO 1h DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO *esporo em diário*

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: sim MALLAMPATI: IV IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Congestão nasal / sinusite

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA *Retirado vesícula*

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Provável *la*

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (X) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS *marc. N30i*

11/06 / PSG - 81.3 - SpO₂ = 75%
24 *sonol. rem = 26 seg.*

PSG c/ CPAP - 25.0 e/ev
SpO₂ - 80%
sono = 14 seg. *lua.*

08/07 / P = 10.5 cmH₂O - Relato obstrução nasal.
24 IAH = 1.4 e/ev - ↑ a umid. e aquecimento.
Fuga = 19.5 lpm *lua cláudia*

08/07 / P = 12 cmH₂O - ↓ 17kg.
25 IAH = 2.0 - dieta *pagou consulta*
Fuga = 21.1 lpm

05/08 P = 10.0 (↓ relato erofagia) (P = 123.700 kg.)
25 IAH = 0.1
Fuga = 0.9 *retorno*
m. de uso: 7m

Nome: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA GRAGLIA

Data de Nascimento: 1-9-1962

IMC: 39,95

Sexo: Masculino

Data do exame: 26-03-2024

Peso: 128 kg

Altura: 1,79 m

Médico: DR. ERCIO ALVARO NAKAKO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 26-03-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 491,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 25,0 e 152,5 minutos. O tempo total de sono foi de 312,0 min, eficiência de 63,5% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 61,2%; estágio N3: 14,1%; sono REM: 22,4%. O índice de despertares foi de 38,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 81,3/hora, sendo 66 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 247 hipopnéias. A SpO2 média foi de 88% e a mínima de 75%, permanecendo 50,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 77 bpm e NREM de 49 - 78 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (07), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 81,3/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=75%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

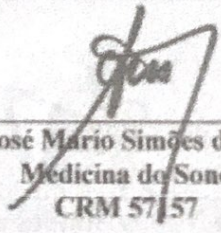
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: LUIZ EDUARDO OLIVEIRA GRAGLIA
Data de Nascimento: 1-9-1962
IMC: 39,95
Sexo: Masculino
Data do exame: 24-04-2024

Peso: 128 kg
Altura: 1,79 m
Médico: DR. ERCIO ALVARO NAKANO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 464,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 32,0 e 111,0 minutos. O tempo total de sono foi de 382,0 min, eficiência de 82,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 65,3%; estágio N3: 13,7%; sono REM: 19,0%. O índice de despertares foi de 17,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,0/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 139 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 80%, permanecendo 17,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 81 bpm e NREM de 50 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. latência para o sono aumentada;
4. aumento do número de despertares breves;
5. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,6/hora);
6. presença de atividade em EMG de queixo;
7. registro de ronco durante o sono.

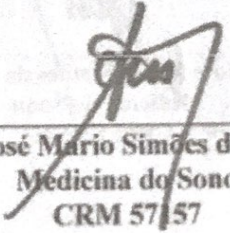
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 9 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157